

Pat.-Nr.: 8237

Name: Derikael Thomas

Datum	Leistungsziffer	Diagnose
4.17 -	↓	Fortsetzung 08.02.23:
645	✓	Sono-Duplex Carotiden + SD: Intima: 0,26 StV: 44,2 re. SD: 8,0cm li. SD: 12,0cm
04		bp: Jodid 100 NS 11
08.02.23	14 ⁴⁵	OS bds
1.9 -	✓	Op. der zenuwen bds
1565	1578	
10.02.23		Hepatitis - Serologie nachgefordert
1.9		

Pat.-Nr.: 8237

Name: Beniffel, Thomas

Datum	Leistungsziffer	Diagnose
9.08.21	14:15	OS bds. gespült Medivitan im v. Pyxis Hörtest ab 3
1565-1578	✓	
1403-CO		
6.02.23	16:00	Check up & HKJ
Anamnese Familienanamnese ☐ negativ Herzinfarkt ☒ nein ☐ _____ Schlaganfall ☒ nein ☐ _____ Tumorerkrankung ☐ nein ☐ Oma beide. Tante Lunge Darmkerkrankung ☒ nein ☐ _____ Nikotinabusus: ☐ ja ☒ nein ☐ Exraucher Gyn. VS _____ Uro. VS _____ Colo ☐ nein Wann? _____ Check up Privat ☐ Größe 189 cm ☐ Gewicht 79 kg ☐ RR ☐ P /min, O2 /min ☒ EKG } bei Bespr. - TE bitte mitmachen ☒ KAI } wg. Personalmangel ☐ Impfstatus ☐ Medikamentenplan abgleichen (PC-Doku) ☒ C9 CB. ☒ iFOBT mitgeben ☒ Colo gemacht? ☒ Lufu 075.272 ☒ BE: P-Labor, Selen ☒ Sono Abdomen		
M		HNO: re. Cerumen obdoliens
		TE OS rechts
		Abdomen: weich, & res.
M		Bspr. TE bei Fr. Dr. lt. Chef

Pat.-Nr.: 8237

Name: Deniffel Thomas

Datum	Leistungsziffer	Diagnose
25.08.21	1000 <u>028.3</u>	
7-626-3	② Lufu simult. 29 o.B.	> Schnelltest ? vollständig gemacht
605-605a	M Hörtest M Sehtest Farbsichttest o.B.	→ mit Brille !
M -		
1403-1228	M EKG M RR 120/80 mmHg	Größe 190cm
602	M O ₂ 98 % P. 43 /min	Gewicht 90kg
682		max. 270kg

Watt	Minuten	RR	HF
75	1	120/80	90
100	2	120/80	99
125	3	130/80	107
150	4	140/80	117
175	5	150/90	134
200	6	160/90	145
225	7	160/90	153
250	8	170/90	163
275	9	190/90	169
25	11	170/80	162
	13	150/70	101

ASL 1 w. Früh Jala Lysol

• Ar. & Herz, & Brust

TE Ohrspülung + Hörtest

Pat.-Nr.:

8237

Name:

Deniffel Thomas

Datum	Leistungsziffer	Diagnose
30.4.21	12:15	Sono Jans. + 1x Medivitan
424		<u>Sono DIAG:</u> Pleura: Ø Erguss, Hohlvene: Ø gestaut, Herz: schöne Bewegung Klappen: zart, Mitralklappe: Ø Verkalkung, Herzgröße: schön geteilt Ø Wandbewegungsstörungen, Pumpfunktion EF 50%. 77% mittlere Herzenebene Druck, Septum: 15 mm zarte Aortenklappe fast Ø sichtbar, Ø Wandbewegungsstörung, gute Pumpfunktion
2521		an 1 Medivitan i.m. v. Praxis
13.5		Tel: Speziallabor z.B. A. Zolicki noch zu empfehlen, → ebenfalls Blutabnahme → d. dann Besprech.-termin in Bttr. Jr.
04.05.21	7:30	Medivitan Ø erschauen
11.5.21	7:30	<u>5. Medivitan</u> i.m. v. Praxis/jc
2521		Besprechung Blutwerte und vorher Prozedere
18.5.21	7:30	Spritze 1x Medivitan i.m. (6.)
25.05.21	8:15	1x Medivitan i.m. Ø erschauen

Privat

Deniffel

Thomas

Ellenberg 116

06.04.94

Name: _____

Behandlungs-Verlauf

Pet. Nr. D-87499 Wildgoldsried

Diagnose

21.04.21

21.4.21

815

Spritze

Medication i.m. von Praxis

Havrix Impf bringt Pat mit

25211

✓

Ich willige ein, zur Injektion

Havrix 1440
Ch.-B.: AHAVB995AM
Verw. bis: 08.2021

Hep. A i.m.

375 Havrix

Hep A
Allergieaufklärung etc. erfolgte

Pat.-Nr.: 8237

Name: Denitzer, Thomas

Datum	Leistungsziffer		Diagnose
15.4.21		11:00 (Besprechung lt chef)	
			31
		RR 130/80	
		O ₂ 94% P 13 l/min	
		Coz / w/ Pp. Harnix 1440 (jetzt 1x) (um 27 Jahr)	
252h		✓ Mit Labor 2x IFOBT (Proben schon b. uns im Labor)	
2010			
401		✓ Bes. Impfstatus	
Co		Dg: dyspnoe, toxisch, allerg. Hauterkrankung einfach. Geradung	
		w/ Pp: Dermoxin Creme	
		Dg: Hyperhomocysteinämie, α-Lipoprote	
		w/ Medication im a. Praxis	
		5x IE für Medication	
		Sonographie Abdomen (33042)	
		Leber: ☒ o.p.B. ☐ erhöht auf Fettleber	
		Nieren: links ☒ o.p.B. ☒ kein Harnstau	
		rechts ☒ o.p.B. ☒ kein Harnstau	
		Pankreas: ☒ o.p.B. ☐ erhöht	Leber u. Niere selbe Größe
		Gallenblase: ☒ o.p.B. ☒ keine Wandverdickung	
		☐ Steine/Gries ☒ Murphy negativ	
		Milz: ☒ o.p.B. ☐ erhöht	
		Große Gefäße: ☒ o.p.B. ☐ erhöht	
		Harnblase: ☒ o.p.B. ☐ erhöht	
		Ergüsse: ☒ keine ☐ Pleura	
		☐ Aszites	
		82 UKG TE b. Frau Dr.	

Pat.-Nr.: 8237

Name: Penffel Roman

Datum	Leistungsziffer	Diagnose
8.4.2021	HKS + VS 8 Uhr + Check	Beruf: Programmier

29.08.21

750

602

KAI

1FOBT

Vorsorge US 39 Eintrag 9.3
Temp 36,8
Kurzfrist u. Befristet
Techn. unzulässig
- aktuelle
- Positive Familienanamnese Tumor
Onk. Mutter → erst. Mamma NPL (9/2020)
Onk. Mutter → auch Tumor, Lokalisation? (2019)
Onk. Vater → Zungenkarzinom b. Nikotinabusus (2018)
- Z.n. Nephrolithiasis

Check up Privat

605 -

605a

Labor P

- ☒ Größe 180cm ☒ Gewicht 100kg
- ☒ RR 118/68 mmHg
- ☒ P 88/min, O2 98% P: 56/min
- ☒ EKG
- ☒ KAI
- ☒ Impfstatus → Impfstatus 2016 vollständig abg. Teilweiser
- ☒ Medikamentenplan abgleichen (PC-Doku) keine Dauermedis
- ☒ C9 0.8
- ☒ iFOBT mitgeben
- ☒ Colo gemacht?
- ☒ Lufu

075.164

BE: P-Rox, Selin, Testosteron, Glamy Hoch, Glamy frei, Lactoferrin, Elastase, Barlose, Mg
Sono Abdom + BW Bespr.

4/7-645

Co

Cor o.B., Puls regelmäßig, 0 Ng
Pulmo frei
Pul Nichtraucher
klin. US unauffällig

Rekt. US: o.B.

HKS unauffällig

TE + m
Zus. Bespr.
(Zeit nah)

lex-Sonographie Carotiden (33050)

Radicke: 0,3 mm; SVp: 24,8 cm/s

ntimasklerose

altersentspr. Gefäßstatus

ographie Schilddrüse (33012)

mm (B/D/L) Vol.: ml

homogene echonormale feingranuläre Binnenstruktur,

n Herdbefund

noten

s: mm (B/D/L) Vol.: ml

homogene echonormale feingranuläre Binnenstruktur,

n Herdbefund

noten

Präventiv kolisch 2007

ontrolle: ☐ ¼ jährlich ☐ ½ jährlich ☐ S: 1-0-0

Pat.-Nr.:

8237

Name:

Demiffel Thomas

Datum

Leistungsziffer

Diagnose

21.1.21

922

Tel. Pat. TE nur OP-Vorbereitung
angeboten, Pat. war schon b. Verleasant

Wj. OP am 16.2., klärt es aber nochmal
ab ob weit. US nötig sind, meldet sich
bei Bedarf

① Plantarfasziensystem Grundjahr 67. u. 70. J.

22.02.21

11:15

2. n. KH, am Donnerstag entlassen
worden, V3 + Bespr. weiteres
Procedere

8/20/21

① Dienstag früh CP gelöst

→ Ø 4 abh. u.

Besprechung KH-Bericht

Pat. seit gestern 4-frei

Kramer-Verband durch Fr.-Dr.

① TE Ende der Woche bei Fr.-Dr. in
Sprechstunde Vbw.

Wunde schaut gut aus,
reizlos

① Ruptur plantare Platte MTP 2 mit
sekundärem Knochenodem zweites
Grundglied links (Fuß)
rez. Synovitis MTP 2
2. n. OP

Ø Heparin-Therapie notwendig H
Arztbrief

Pat.-Nr.:

8237

Name:

Deniffel Thomas

Datum	Leistungsziffer	Diagnose
5.4.19	16:40 OS	Ø Pat nicht erschienen!!
6.5.19	RG 863/17 v. 8.10.17 an neue ✓ Anschrift gedruckt!	
27.01.20	10:30 Knieschmerz Ø abgesagt	
15.04.20	14:00 OS Ø 1565 1578	bds Ø Cerumen obturans bds
4.6.20	12.7.20	
21.7.2020	HEB an INTER-US an 27.7.20 an Pat. zum gegenlesen	
16.10 - 20	Antrag Darter Versicherung	
26.10.20	1. Einweisung HST/MS Ø an VS gest. 12.11.2020 HST INTER-US	
Ø V	an 23.11.2020	- an VS gest./k

Pat.-Nr.:

Name: Deniffel Thomas

Datum

Leistungsziffer

Diagnose

252 2^o Dyn
an

Fortsetzung 25.8.17
Stenokardie bei BWS Syndrom
HNO / CIP o.B.

651-

657

1 Dynastat i.m. } a. Praxis
1 Medivitan i.m. }
EKG → SIST II, III Typ

21.09.17

8:00

Ø gekommen

① A. mit. Systemerkrankung

28.09.17

8.10

Check up Privat

- ☒ Größe 190cm
- ☒ Gewicht 87kg
- ☒ RR 100/60
- ☒ P 55 /min, O2 98 /min
- ☒ EKG 25.8.17
- ☒ KAI
- ☐ Impfstatus
- ☒ Medikamentenplan abgleichen (PC-Doku)
- ☐ C9
- ☒ iFOBT mitgeben
- ☒ Colo gemacht?
- ☒ Lufu
- ☐ BE: Gluc, HDL, LDL, Chd, Harnsäure, Kreat, Bl. BB
- ☒ Sono Abdomen

17.800

602

637-643

mm

605-605a

075 963

Labor

1565

1578

HNO: Cerumen obtians rechts und links
Rachen eng / verschl. E

Cor: Ø NG, HT ren + rhythmisch
Pulma: fr, satenged, Ø RGS

WS: o.B. Ø KS

Cutis: Acne vulgaris comedonica am Rücken

Ohrspekulum bds., Cerumen bds.

✓ Rp. Epiduo

863/17

8.10.17

Pat.-Nr.:

Name:

Beniffel Thomas

Datum

Leistungsziffer

Diagnose

17.3.17 10:00

✓

pat. rief an und meinte er sei gerade in Spanien und schreibt dort seine Bachelorarbeit. Er musste allerdings die letzte drei tage wg Nierensteinen und Mikrhämaturie ins Krankenhaus und konnte arbeit nur bedingt fertigstellen wg Zeitmangel. in Spanien ist es allerdings so das die ärzte dort keine AUs ausstellen er hat lediglich eine bestätigung bekommen das er von mittwoch-freitag im KH war. Schule braucht jetzt aber AU.
Laut Chef können wir AU schon ausstellen er soll uns vorher die Bestätigung faxen.

20.03.17 10:00 → Patient meldet sich wenn er Attest braucht

74117 16.4.17

24.04.17 10³⁰ durch d. Pd. seine Rechnungsmittelgen sind abhandeln gekommen

Pd. bitte um nochmalige Zurechnung v. Rechnung
10.01.17 + 16.04.17

Danke am 25.4.17 grl. C.E

15.8.17 19:00

Attest für Befreiung von Prüfung morgen

1-8-✓

• Attest Prüfungsunfähig

2010

Sono Attest: z.n. Nierenstein

↓

Narbige Phimose bei ca. 6 Wochen ruher weiter mit Dermoxil - Creme

Privat

Deniffel

Thomas

Haldenweg 7A

06.04.94

Name:

Behandlungs-Verlauf

D. 87499 Wildpoldsried

Diagnose

03.02.17

03.02.17

1830

Rp: Twinrix N₁ 1 Spritze
Dakorad N₁ 2 x 1 Stk.

375

Twinrix Erwachsene
Ch.-B.: AHABB346AE
Verw. bis: 07.2018

57419
001-03

A

09.01.17

9:00

H Chef Pat. fliegt
Nachmittags nach Spanien

✓ 8

Sono d. pers. Entesepathie ^M Ansatz Rektus - Abdominis re. u. Kom
~~Handstüb~~ re. , Aductoren re. Beulen ^{pubis}

252² Dyn

M

Sono Adel

Sono = O.B.

① Forttheropathie Adhäsionen am OS
OS pubis re.

267 TX

✓ Dynastat im von Praxis
Medunitan im von Praxis

Trinico (Kylsiphil)

✓ TE Antwort für Spitz Dynastat + Medunitan

1198/16 10.1.17

1.1.17

9:30

Spitze

17. 252² ② Medunitan im (v. Praxis)

1 f Kontraktion li. Ellenbogen (Dr. Scherzgerken)

3.2.17 o.T 830 Uhr. Veldner bel

✓ auf 35 utop → Hcent aussch.

252³ h

② medunitan im von Praxis

PC: Petrich David
mit Wölfler, Christoph

Seit 1.12.16 Privat - Versichert, vorheriger
Hausarzt Dr. Mayer Wildpoldsried

19.12.16

19:30h

Seit 3/16 4 (ist 2) li
ber bei Abduktion; → wunde schmerzen
Vorherpes genitalis

Repr. Gucke, Blende → Rucke → Entzündung
mit Rhytoiden Bild, (Dauer ca 10-15 min)
5.11 u. 12.16

✓ PCR auf Herpes Genitales
Infekt: Trinitro + Klyen
OG: Rote Adduktoren mit Enthesopathie Os pubis
-syndrom Schüttel - fehlte bei

075 645

✓ BE P-Labor, Chlamydien hoch, PTHA-Test

✓ Rp. Decoderm hi
Trottop - Gel

Termin am Montag
9.01.17